BVĐK NHẬT TÂN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
HỘI ĐỒNG QLCL	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05/KH-BVNT	*Châu Đốc, ngày 08 tháng 01 năm 2026*

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CHUNG NĂM 2026

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÍNH CẤP THIẾT

1. Cơ sở pháp lý

• Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế quy định về hướng dẫn việc quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

• Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam;

• Căn cứ Thông tư số 35/2024/TT-BYT, ngày 16/11/2024 của Bộ Y tế quy định về Tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với bệnh viện;

• Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-BYT, ngày 04/06/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh";

• Căn cứ Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai bệnh viện xanh sạch đẹp;

• Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/07/2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế;

• Căn cứ Quyết định số 7482/QĐ-BYT ngày 18/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật;

• Căn cứ Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ Y tế ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học;

• Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

• Căn cứ theo kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2025;

• Bệnh viện Nhật Tân xây dựng Kế hoạch cải tiến chất lượng chung năm 2026.

2. Tính cấp thiết

Qua khảo sát thực trạng năm 2025, thời gian chờ đợi khám bệnh và nhận thuốc giờ cao điểm vẫn còn dài, các khâu di chuyển cận lâm sàng và thanh toán còn tình trạng ùn ứ cục bộ. Do đó, việc xây dựng và triển khai Đề án cải tiến chất lượng đồng bộ, tích hợp hệ thống Robot cấp phát thuốc tự động là giải pháp đột phá nhằm giảm tối đa thời gian chờ đợi, nâng cao an toàn dùng thuốc và tăng chỉ số hài lòng của người bệnh ngoại trú lên ≥90%.

3. Mục tiêu

3.1. Mục tiêu chung:

Nâng cao chất lượng, an toàn và hiệu quả hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; tập trung cải tiến đồng bộ và hiện đại hóa quy trình khám bệnh ngoại trú, lấy ứng dụng robot cấp phát thuốc tại Khoa Dược làm trọng tâm, kết hợp chuẩn hóa quy trình, liên thông dữ liệu, cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm giảm thời gian chờ đợi, giảm di chuyển không cần thiết và tăng sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng (QLCL), xây dựng môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp và duy trì, cải tiến chất lượng (CTCL) tại các khoa, phòng trong toàn bệnh viện.

3.2. Các Mục Tiêu:

Mục tiêu	Chỉ tiêu đề xuất đến cuối năm 2026	Chủ trì
1. Kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng và triển khai các đề án cải tiến chất lượng	Hoàn thành rà soát, kiện toàn Hội đồng, Tổ và mạng lưới QLCL trong quý I/2027; 100% khoa, phòng có đầu mối và được phân công nhiệm vụ QLCL. 100% khoa, phòng đăng ký vấn đề ưu tiên; ≥90% khoa, phòng xây dựng và triển khai đề án CTCL riêng; 100% đề án có số liệu nền, mục tiêu đo lường được và báo cáo đánh giá kết quả trước–sau.	- Chủ trì: Hội đồng QLCL, Tổ QLCL. - Phối hợp: TCHC và trưởng các khoa, phòng.
2. Cải tiến đồng bộ và hiện đại hóa quy trình khám bệnh ngoại trú	Hoàn thành rà soát, chuẩn hóa các khâu tiếp đón, khám bệnh, cận lâm sàng, thanh toán và cấp phát thuốc. Giảm ít nhất 20% thời gian trung vị hoàn tất một lượt khám so với trước cải tiến, đánh giá riêng nhóm có và không thực hiện cận lâm sàng. Đưa robot cấp phát thuốc vào vận hành theo tiến độ được duyệt; sau khi vận hành ổn định, giảm ít nhất 50% thời gian trung vị từ tiếp nhận đơn đủ điều kiện cấp phát đến bàn giao đủ thuốc. Triển khai đăng ký khám trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và liên thông dữ liệu phục vụ quy trình khám bệnh; hoàn thành các hạng mục cải tạo không gian, biển chỉ dẫn và tiện ích theo kế hoạch được phê duyệt.	**- Chủ trì điều phối:** Khoa Khám bệnh, KHTH. **- Chủ trì cấp phát thuốc:** Khoa Dược. **- Phối hợp:** CNTT, TCKT, các khoa cận lâm sàng, CSKH, TCHC và bộ phận trang thiết bị.
3. Xây dựng và duy trì bệnh viện xanh, sạch, đẹp, ngăn nắp và thuận tiện	100% khoa, phòng, bộ phận triển khai và duy trì 5S; ≥90% lượt kiểm tra đạt yêu cầu theo bảng kiểm nội bộ. 100% khu vực công cộng, khu chờ và nhà vệ sinh có phân công vệ sinh, kiểm tra và ghi nhận hằng ngày. Hoàn thành các hạng mục cải thiện cảnh quan, bố trí cây xanh tại những vị trí phù hợp theo kế hoạch được duyệt.	**- Chủ trì:** TCHC, KSNK. **- Phối hợp:** Tổ 5S, bộ phận vệ sinh và các khoa, phòng.
4. Tăng cường an toàn người bệnh, phòng ngừa và giảm thiểu sự cố y khoa	100% nhân viên y tế được tập huấn, hướng dẫn về an toàn người bệnh và báo cáo sự cố y khoa; ≥95% nhân viên được đánh giá đạt yêu cầu sau tập huấn. 100% sự cố được tiếp nhận qua hệ thống báo cáo được phân loại, xem xét và xử lý theo mức độ; các sự cố cần phân tích có giải pháp khắc phục và theo dõi thực hiện. 100% khoa, phòng liên quan triển khai giám sát nhận diện người bệnh, phòng ngừa trượt ngã, sử dụng thuốc an toàn và kiểm soát nhiễm khuẩn. Tăng ít nhất 10% số báo cáo tình huống suýt xảy ra sự cố được ghi nhận hợp lệ so với năm 2025.	**- Chủ trì:** Tổ QLCL, KHTH. **- Phối hợp:** Điều dưỡng, Khoa Dược, KSNK và các khoa lâm sàng, cận lâm sàng.
5. Nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của	Duy trì tỷ lệ hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên y tế ≥90% ở từng nhóm khảo sát. Thực hiện khảo sát người bệnh ít nhất mỗi quý một lần, nhân viên y tế ít nhất hai lần/năm. 100% vấn đề ưu tiên được xác định từ khảo sát và	**- Chủ trì:** CTXH/CSKH. **- Phối hợp:** Điều dưỡng, TCHC, bộ

người bệnh, nhân viên y tế	phản ánh có đơn vị phụ trách, biện pháp xử lý và thời hạn hoàn thành. Triển khai ít nhất một hoạt động cải tiến dịch vụ nội trú và một hoạt động cải tiến chất lượng suất ăn hoặc dịch vụ căn tin, có đánh giá kết quả.	phận dinh dưỡng, KSNK và các khoa, phòng.
6. Hoàn thiện việc đo lường, giám sát và sử dụng chỉ số chất lượng để cải tiến	Ban hành bộ chỉ số chất lượng ưu tiên trong quý I/2027; 100% chỉ số có định nghĩa, cách tính, nguồn dữ liệu, tần suất thu thập và người phụ trách. Theo dõi, báo cáo hằng tháng các chỉ số trọng tâm về thời gian khám bệnh, cấp phát thuốc và an toàn; các chỉ số khác thực hiện theo tần suất được phê duyệt. 100% đề án CTCL được theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả bằng chỉ số phù hợp.	**- Chủ trì:** Tổ QLCL. **- Phối hợp:** CNTT, KHTH và các khoa, phòng phụ trách chỉ số.
7. Duy trì và nâng cao chất lượng toàn viện	Tổ chức tự đánh giá chất lượng bệnh viện giữa năm và cuối năm; 100% tồn tại được xác định qua đánh giá có phân công khắc phục và thời hạn thực hiện. Duy trì đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cơ bản áp dụng đối với bệnh viện; không có tiêu chí mức 1; phấn đấu điểm trung bình chất lượng bệnh viện đạt ≥3,71 theo bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá áp dụng.	**- Chủ trì:** Hội đồng QLCL. **- Đầu mối thực hiện:** Tổ QLCL. - **Phối hợp:** Tất cả các khoa, phòng.

3.3. Yêu cầu

- Tất cả nhân viên và người lao động trong bệnh viện có trách nhiệm tham gia hoạt động QLCL, CTCL phù hợp với vị trí công tác và nhiệm vụ được giao.
- Hoạt động CTCL được triển khai thường xuyên, liên tục, gắn với hoạt động chuyên môn và kế hoạch công tác của từng khoa, phòng.
- Các khoa, phòng lựa chọn vấn đề cải tiến dựa trên thực trạng, số liệu, nguy cơ và nhu cầu của người bệnh; bảo đảm phù hợp với mục tiêu chung và nguồn lực của bệnh viện.
- Mỗi đề án, hoạt động cải tiến phải xác định rõ người chịu trách nhiệm, đơn vị phối hợp, chỉ tiêu, tiến độ, nguồn lực và kết quả đầu ra.
- Các giải pháp giảm thời gian chờ phải đồng thời bảo đảm an toàn, chất lượng chuyên môn và thời gian tư vấn cần thiết cho người bệnh.
- Việc thu thập, báo cáo và đánh giá số liệu phải chính xác, trung thực, thống nhất phương pháp; khuyến khích báo cáo sự cố và tình huống suýt xảy ra sự cố để học tập, phòng ngừa.
- Định kỳ đánh giá tiến độ, điều chỉnh giải pháp đối với mục tiêu chưa đạt và duy trì các cải tiến đã chứng minh hiệu quả.

II. NỘI DUNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NĂM 2026

1. Kiện toàn hệ thống QLCL và triển khai các đề án CTCL

1.1. Kiện toàn hệ thống QLCL

- Rà soát, kiện toàn Hội đồng QLCL, Tổ QLCL và mạng lưới QLCL tại các khoa, phòng; cập nhật quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và cơ chế phối hợp.

- Bảo đảm 100% khoa, phòng có nhân sự đầu mối phụ trách QLCL; xác định rõ trách nhiệm của trưởng khoa, phòng và thành viên mạng lưới trong việc triển khai, giám sát và báo cáo hoạt động cải tiến.
- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn về lựa chọn vấn đề ưu tiên, xây dựng đề án, đo lường chỉ số và đánh giá hiệu quả cải tiến.
- Duy trì họp Hội đồng QLCL ít nhất mỗi quý một lần; kết luận cuộc họp xác định rõ công việc, người phụ trách và thời hạn hoàn thành.

1.2. Xây dựng và triển khai đề án CTCL tại các khoa, phòng

- Mỗi khoa, phòng rà soát thực trạng, tổ chức thảo luận và lựa chọn vấn đề ưu tiên dựa trên số liệu hoạt động, nguy cơ, kết quả đánh giá chất lượng và phản ánh của người bệnh, nhân viên.
- Các đơn vị tham gia hoạt động khám bệnh ngoại trú ưu tiên đề án góp phần cải tiến quy trình chung, giảm thời gian chờ, nâng cao an toàn và chất lượng phục vụ.
- Các khoa nội trú và đơn vị khác lựa chọn vấn đề phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, gắn với các mục tiêu chất lượng của bệnh viện.
- Tổ QLCL hướng dẫn xây dựng đề án, bảo đảm có số liệu nền, mục tiêu đo lường được, giải pháp, người phụ trách, tiến độ, kinh phí và phương pháp đánh giá.
- Hội đồng QLCL xem xét, góp ý; trình lãnh đạo bệnh viện phê duyệt theo thẩm quyền trước khi triển khai.
- Định kỳ theo dõi tiến độ; đánh giá kết quả trước–sau, xác định nguyên nhân chưa đạt và thực hiện điều chỉnh. Chuẩn hóa, duy trì và nhân rộng các giải pháp có hiệu quả.

DANH SÁCH ĐỀ ÁN DỰ KIẾN TRIỂN KHAI

Khoa/phòng/ bộ phận	Tên đề án đề xuất	Kết quả cần đo lường	Trách nhiệm
Khoa Dược	Ứng dụng robot và cải tiến quy trình cấp phát thuốc ngoại trú nhằm giảm thời gian chờ và bảo đảm an toàn người bệnh	Đưa robot vào vận hành theo tiến độ được duyệt; giảm ít nhất 50% thời gian trung vị từ tiếp nhận đơn đủ điều kiện cấp phát đến bàn giao đủ thuốc so với trước cải tiến; theo dõi tỷ lệ sai sót cấp phát và mức độ hài lòng của người bệnh khi nhận thuốc.	**- Chủ trì:** Khoa Dược **- Phối hợp** TTB, Khoa khám bệnh
Khoa Khám bệnh	Cải tiến quy trình tiếp đón, tổ chức khám bệnh và hướng dẫn người bệnh nhằm giảm thời gian chờ và nâng cao chất lượng phục vụ	Giảm ít nhất 20% thời gian một lượt khám so với trước cải tiến; tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngoại trú đạt ≥90%	**- Chủ trì:** Khoa Khám bệnh **- Phối hợp** với cận lâm sàng, TCKT và Khoa Dược để đạt chỉ tiêu thời gian của toàn bộ lượt khám
CNTT	Cải tiến giao diện, nội dung và tiện ích website bệnh viện nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người bệnh	Hoàn thành nâng cấp website trong năm 2027; cập nhật nội dung ít nhất hằng tuần; 100% thông tin về lịch khám, dịch vụ và bảng giá được cập nhật khi có thay đổi; ≥90% người dùng được khảo sát hài lòng về khả năng tra cứu thông tin.	**- Chủ trì:** CNTT **- Phối hợp** CTXH và các khoa, phòng cung cấp, kiểm tra nội dung.
Tài chính – Kế toán	Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tạo thuận tiện và giảm thời gian chờ thanh toán của người bệnh	Tăng số quầy hỗ trợ và đa dạng hóa hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; tăng tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt trên tổng số giao dịch; giảm thời gian chờ thanh toán so với trước cải tiến.	**- Chủ trì:** Phòng Tài chính – Kế toán **- Phối hợp:** CNTT, Khoa Khám bệnh và CTXH.
Xét nghiệm	Cải tiến quy trình lấy mẫu, vận chuyển và	Giảm thời gian từ khi lấy mẫu đến khi kết quả được duyệt và sẵn sàng cho bác sĩ tra	**- Chủ trì:** Khoa Xét nghiệm.

	xử lý mẫu nhằm rút ngắn thời gian trả kết quả xét nghiệm ngoại trú	cứu; tăng tỷ lệ trả kết quả đúng thời gian hẹn theo từng nhóm xét nghiệm	- **Phối hợp:** Khoa Khám bệnh, Điều dưỡng, CNTT và bộ phận trang thiết bị
CĐHA – TDCN	Cải tiến quy trình tiếp nhận, điều phối và trả kết quả chẩn đoán hình ảnh – thăm dò chức năng nhằm giảm thời gian chờ của người bệnh ngoại trú	Giảm thời gian chờ từ khi tiếp nhận đến khi thực hiện kỹ thuật; giảm thời gian từ khi hoàn tất kỹ thuật đến khi kết quả được duyệt và sẵn sàng cho bác sĩ tra cứu	- **Chủ trì:** Khoa CĐHA – TDCN. - **Phối hợp:** Khoa Khám bệnh, KHTH, CNTT và CTXH.
Điều dưỡng	Chuẩn hóa việc bố trí, quản lý và sử dụng xe tiêm thuốc nhằm nâng cao an toàn và hiệu quả chăm sóc người bệnh	Tỷ lệ xe tiêm thuốc đạt bảng kiểm chuẩn hóa về bố trí, vật tư và vệ sinh; tỷ lệ tuân thủ kiểm tra, bổ sung và sắp xếp xe trước khi sử dụng; giảm thời gian chuẩn bị và số lần gián đoạn do thiếu vật tư so với trước cải tiến.	- **Chủ trì:** Phòng Điều dưỡng. - **Phối hợp:** Khoa Dược, KSNK, bộ phận vật tư – thiết bị và các khoa lâm sàng.
CTXH	Nâng cao hiệu quả truyền thông và tư vấn dịch vụ phòng VIP Khoa Phụ sản nhằm thu hút khách hàng và tăng hiệu quả sử dụng dịch vụ	Tăng số khách hàng được tư vấn về dịch vụ; tăng tỷ lệ khách hàng lựa chọn phòng VIP sau tư vấn; tăng công suất sử dụng phòng VIP so với trước cải tiến; tỷ lệ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ đạt ≥90%.	- **Chủ trì:** CSKH. - **Phối hợp:** Khoa Phụ sản, Điều dưỡng, CNTT và TCKT.
TCHC, bảo vệ	Cải tiến công tác đón tiếp, tổ chức bãi đậu xe và phân luồng giao thông nhằm giảm ùn tắc, tạo thuận tiện cho người bệnh	Giảm thời gian chờ gửi, lấy xe và tìm vị trí đậu xe; giảm số lần và thời gian ùn tắc tại cổng, bãi xe trong giờ cao điểm; tăng tỷ lệ phương tiện đậu đúng khu vực quy định; tỷ lệ hài lòng về hướng dẫn, giữ xe và hỗ trợ người cần ưu tiên đạt ≥90%.	-**Chủ trì:** Phòng TCHC - **Phối hợp:** Khoa Khám bệnh, CTXH/CSKH và Khoa HSCC.
KSNK, vệ sinh	Cải tiến công tác vệ sinh khu khám bệnh, khu chờ và nhà vệ sinh nhằm bảo đảm môi trường sạch sẽ, an toàn và nâng cao sự hài lòng của người bệnh	≥90% lượt kiểm tra đạt yêu cầu theo bảng kiểm vệ sinh; 100% khu vực được phân công vệ sinh, kiểm tra và ghi nhận hằng ngày; giảm thời gian xử lý khi phát hiện khu vực chưa sạch hoặc có phản ánh; tỷ lệ hài lòng về vệ sinh đạt ≥90%.	- **Chủ trì:** Khoa KSNK - **Phối hợp:** TCHC, Khoa Khám bệnh và CTXH.
KHTH	Cải tiến hoạt động ghi nhận, báo cáo và phản hồi sự cố y khoa nhằm nâng cao an toàn người bệnh	Tăng số báo cáo sự cố y khoa được ghi nhận hợp lệ; tăng ít nhất 10% số báo cáo tình huống suýt xảy ra sự cố (near miss) so với năm 2025; 100% báo cáo được phân loại, xem xét và phản hồi; theo dõi tỷ lệ hoàn thành các biện pháp khắc phục, phòng ngừa	- **Chủ trì:** Phòng KHTH. - **Phối hợp:** Tổ QLCL, Điều dưỡng, Khoa Dược, KSNK và các khoa lâm sàng, cận lâm sàng
Các khoa nội trú	Mỗi khoa lựa chọn và xây dựng đề án cải tiến một vấn đề ưu tiên về an toàn người bệnh hoặc chất lượng chuyên môn phù hợp với thực trạng của khoa	Mỗi đề án có số liệu nền, mục tiêu cụ thể và chỉ số đánh giá trước–sau; đo lường kết quả phù hợp với vấn đề lựa chọn như tỷ lệ tuân thủ bàn giao, nhận diện người bệnh, sử dụng thuốc, phòng ngừa té ngã hoặc thực hiện hướng dẫn chuyên môn.	- **Chủ trì:** Trưởng từng khoa nội trú. - **Phối hợp:** Tổ QLCL, KHTH, Điều dưỡng và các đơn vị liên quan
Tổ QLCL	Chuẩn hóa công tác xây dựng kế hoạch,	≥90% khoa, phòng xây dựng và triển khai đề án CTCL; 100% đề án có số liệu nền,	- **Chủ trì:** Tổ QLCL. - **Phối hợp:** Hội đồng

	hướng dẫn đề án và giám sát cải tiến chất lượng toàn viện	mục tiêu đo lường được và báo cáo đánh giá trước–sau; 100% đề án được giám sát theo lịch; theo dõi tỷ lệ hoàn thành đúng tiến độ và tỷ lệ đạt mục tiêu của các đề án.	QLCL, trưởng các khoa, phòng và mạng lưới QLCL.

Danh sách trên mang tính định hướng. Các khoa, phòng có thể đề xuất vấn đề khác phù hợp hơn với thực trạng, gửi Tổ QLCL tổng hợp, trình xem xét. Bộ phận bảo vệ, vệ sinh và các tổ trực thuộc có thể thực hiện hợp phần trong đề án của đơn vị quản lý, với nhiệm vụ và chỉ số riêng.

Tổ chức thực hiện và kết quả đầu ra:

- Chủ trì: Hội đồng QLCL, Tổ QLCL.
- Phối hợp: TCHC và trưởng các khoa, phòng.
- Tiến độ: Kiện toàn tổ chức, đăng ký và phê duyệt đề án trong quý I; triển khai trong quý II–III; đánh giá, tổng kết trong quý IV/2026.
- Kết quả: 100% khoa, phòng có đầu mối QLCL và đăng ký vấn đề ưu tiên; ≥90% khoa, phòng xây dựng, triển khai đề án riêng; 100% đề án có số liệu nền, mục tiêu đo lường được và báo cáo đánh giá trước–sau.

2. Cải tiến đồng bộ và hiện đại hóa quy trình khám bệnh ngoại trú

2.1. Rà soát và tổ chức lại quy trình khám bệnh

- Khảo sát toàn bộ hành trình người bệnh từ khi đến bệnh viện, đăng ký, khám, thực hiện cận lâm sàng, thanh toán đến nhận thuốc và ra về.
- Đo thời gian chờ, thời gian thực hiện và số lần di chuyển; xác định các điểm ùn ứ, thao tác trùng lặp và thủ tục chưa hợp lý.
- Chuẩn hóa quy trình tiếp đón, phân luồng, gọi số, điều phối phòng khám và xử lý trường hợp cần ưu tiên.
- Bố trí nhân lực, quầy tiếp nhận và thời gian phục vụ phù hợp với lưu lượng người bệnh, đặc biệt trong giờ cao điểm.
- Tổ chức thực hiện cận lâm sàng theo trình tự thuận tiện; cải tiến phối hợp trả kết quả, khám lại và hoàn tất đơn thuốc.

2.2. Ứng dụng robot cấp phát thuốc tại Khoa Dược

- Chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng điện, mạng, thiết bị và kết nối phần mềm theo yêu cầu triển khai.
- Chuẩn hóa danh mục thuốc, dữ liệu kết nối và quy trình tiếp nhận đơn, soạn thuốc, kiểm tra, bàn giao, tư vấn.
- Tổ chức phối hợp cấp phát thuốc qua robot với thuốc lấy thủ công, bảo đảm người bệnh nhận đủ thuốc, đúng đơn.
- Đào tạo, đánh giá năng lực nhân viên; kiểm thử và nghiệm thu trước khi vận hành chính thức.

- Xây dựng phương án cấp phát dự phòng khi robot, điện, mạng hoặc phần mềm gặp sự cố.
- Theo dõi thời gian cấp phát, sai sót, thời gian gián đoạn và khối lượng công việc để điều chỉnh quy trình.

2.3. Chuyển đổi số và cải tiến thủ tục

- Triển khai đăng ký khám trực tuyến và qua điện thoại; duy trì hỗ trợ trực tiếp cho người bệnh chưa thuận tiện sử dụng công nghệ.
- Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; cải tiến đối soát và xử lý giao dịch.
- Cải tiến phần mềm Viettel HIS, kết nối dữ liệu tiếp nhận, khám bệnh, cận lâm sàng, thanh toán và cấp phát thuốc.
- Rà soát việc triển khai, hoàn thiện và vận hành bệnh án điện tử theo kế hoạch chuyển đổi số và yêu cầu áp dụng.
- Phát triển tiện ích để người bệnh tra cứu đơn thuốc, kết quả cận lâm sàng và lịch hẹn tái khám, bảo đảm phân quyền và bảo mật thông tin.
- Cập nhật website, Facebook và các kênh thông tin chính thức về quy trình khám, lịch khám, dịch vụ và hướng dẫn sử dụng tiện ích số.

2.4. Cải tạo không gian và tiện ích Khoa Khám bệnh

- Bố trí lại quầy tiếp nhận, khu chờ, biển chỉ dẫn, sơ đồ và các điểm hỗ trợ.
- Cải thiện ghế ngồi, ánh sáng, thông thoáng và lối di chuyển; tạo thuận lợi cho người cao tuổi, người khuyết tật và người cần hỗ trợ.
- Thống nhất hình thức biển bảng, nhận diện và thông tin hướng dẫn trong khu khám bệnh.

Tổ chức thực hiện và kết quả đầu ra:

- **Chủ trì điều phối:** Khoa Khám bệnh, KHTH; Khoa Dược chủ trì hợp phần cấp phát thuốc.
- **Phối hợp:** CNTT, TCKT, các khoa cận lâm sàng, CTXH, TCHC và bộ phận trang thiết bị.
- **Tiến độ:** Khảo sát, chuẩn hóa trong quý I; triển khai theo tiến độ từng hạng mục được phê duyệt; đánh giá trong năm và tổng kết quý IV/2026.
- **Kết quả:** Giảm ít nhất 20% thời gian trung vị hoàn tất lượt khám, phân tích riêng nhóm có và không làm cận lâm sàng; sau khi robot vận hành ổn định, giảm ít nhất 50% thời gian trung vị từ tiếp nhận đơn đủ điều kiện đến bàn giao đủ thuốc. Hoàn thành các hạng mục chuyển đổi số, cải tạo không gian theo kế hoạch được duyệt.

3. Xây dựng và duy trì bệnh viện xanh, sạch, đẹp, ngăn nắp và thuận tiện

Nội dung hoạt động:

- Rà soát vệ sinh môi trường, cảnh quan, khu chờ, hành lang, nhà vệ sinh và các khu vực phục vụ người bệnh.
- Phân công rõ đơn vị, nhân viên phụ trách vệ sinh từng khu vực; quy định tần suất thực hiện, kiểm tra và thời gian khắc phục khi chưa đạt.

- Bảo đảm nhà vệ sinh có đủ phương tiện cần thiết, sạch sẽ, khô ráo; kiểm tra và ghi nhận hằng ngày.
- Tập huấn, thực hiện và duy trì 5S tại các khoa, phòng, bộ phận; bố trí vật dụng, hồ sơ, thuốc và thiết bị gọn gàng, dễ tìm, dễ sử dụng.
- Bố trí góc cây xanh tại những vị trí phù hợp, bảo đảm yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn và không cản trở lối đi.
- Thực hiện phân loại chất thải, giảm thiểu chất thải nhựa và sử dụng tiết kiệm nguồn lực.
- Kiểm tra định kỳ, phản hồi kết quả đến từng đơn vị và theo dõi việc khắc phục.

Tổ chức thực hiện và kết quả đầu ra:

- **Chủ trì:** TCHC, KSNK.
- **Phối hợp:** Tổ 5S, bộ phận vệ sinh và các khoa, phòng.
- **Tiến độ:** Rà soát, phân công trong quý I; thực hiện và giám sát thường xuyên trong năm.
- **Kết quả:** 100% khoa, phòng, bộ phận triển khai và duy trì 5S; ≥90% lượt kiểm tra đạt bảng kiểm nội bộ; 100% khu vực công cộng, khu chờ và nhà vệ sinh được phân công vệ sinh, kiểm tra và ghi nhận hằng ngày.

4. Tăng cường an toàn người bệnh, phòng ngừa và giảm thiểu sự cố y khoa

4.1. Tập huấn và củng cố hệ thống báo cáo sự cố

- Tập huấn về an toàn người bệnh, nhận diện nguy cơ và cách báo cáo sự cố, bao gồm tình huống suýt xảy ra sự cố.
- Duy trì các kênh báo cáo thuận tiện; khuyến khích báo cáo trung thực để học tập và cải tiến.
- Phân loại, xem xét và xử lý sự cố theo mức độ; phân tích nguyên nhân đối với các trường hợp cần thiết.
- Phân công thực hiện giải pháp khắc phục, theo dõi hiệu quả và phản hồi bài học đến các đơn vị liên quan.

4.2. Bảo đảm nhận diện và trao đổi thông tin chính xác

- Rà soát, chuẩn hóa việc xác nhận người bệnh trước khi cung cấp dịch vụ, lấy mẫu, thực hiện kỹ thuật và cấp phát thuốc.
- Hoàn thiện quy trình bàn giao giữa nhân viên, giữa khoa/phòng và khi chuyển người bệnh.
- Chuẩn hóa việc tiếp nhận, xác nhận và ghi nhận thông tin quan trọng, đặc biệt trong tình huống khẩn cấp và y lệnh miệng.

4.3. Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý

- Chuẩn hóa quy trình quản lý, kê đơn, cấp phát và sử dụng thuốc; chú trọng các nguy cơ phát sinh khi chuyển sang quy trình tích hợp robot.
- Kiểm soát thuốc dễ nhầm lẫn, thuốc nguy cơ cao và các bước kiểm tra trước bàn giao.

- Tăng cường dược lâm sàng, thông tin thuốc, tư vấn sử dụng và theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

4.4. Bảo đảm an toàn phẫu thuật, thủ thuật

- Duy trì bảng kiểm an toàn; kiểm tra đúng người bệnh, đúng vị trí, đúng phương pháp và các điều kiện cần thiết trước thực hiện.
- Giám sát tuân thủ, phân tích tồn tại và triển khai biện pháp khắc phục.

4.5. Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn

- Bảo đảm phương tiện, vật tư và điều kiện thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Cập nhật quy trình, tập huấn và giám sát vệ sinh tay, phòng ngừa chuẩn, vệ sinh môi trường và các nội dung liên quan.
- Ứng dụng bảng kiểm điện tử và bảng tổng hợp kết quả để theo dõi, phản hồi và cải tiến.

4.6. Bảo đảm an toàn môi trường và trang thiết bị

- Rà soát nguy cơ trượt ngã, sàn ướt, chướng ngại vật, thiếu ánh sáng, mất an toàn điện, cháy nổ và sử dụng thiết bị.
- Bổ sung cảnh báo, phương tiện hỗ trợ và xử lý vị trí có nguy cơ.
- Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị và tập huấn xử lý tình huống theo kế hoạch.

Tổ chức thực hiện và kết quả đầu ra:

- **Chủ trì:** Tổ QLCL, KHTH.
- **Phối hợp:** Điều dưỡng, Khoa Dược, KSNK, TCHC, bộ phận trang thiết bị và các khoa lâm sàng, cận lâm sàng.
- **Tiến độ:** Thực hiện thường xuyên trong năm; đánh giá định kỳ và sau các sự cố cần phân tích.
- **Kết quả:** 100% nhân viên y tế được tập huấn, hướng dẫn; ≥95% nhân viên được đánh giá đạt sau tập huấn; 100% sự cố tiếp nhận được phân loại, xem xét và xử lý theo mức độ. Tăng ít nhất 10% số báo cáo tình huống suýt xảy ra sự cố hợp lệ so với năm 2025; trường hợp số liệu nền bằng 0 hoặc chưa đầy đủ, xác lập chỉ tiêu phù hợp sau rà soát và trình phê duyệt.

4. Tăng cường an toàn người bệnh, phòng ngừa và giảm thiểu sự cố y khoa

4.1. Tập huấn và củng cố hệ thống báo cáo sự cố

- Tập huấn về an toàn người bệnh, nhận diện nguy cơ và cách báo cáo sự cố, bao gồm tình huống suýt xảy ra sự cố.
- Duy trì các kênh báo cáo thuận tiện; khuyến khích báo cáo trung thực để học tập và cải tiến.
- Phân loại, xem xét và xử lý sự cố theo mức độ; phân tích nguyên nhân đối với các trường hợp cần thiết.
- Phân công thực hiện giải pháp khắc phục, theo dõi hiệu quả và phản hồi bài học đến các đơn vị liên quan.

4.2. Bảo đảm nhận diện và trao đổi thông tin chính xác

- Rà soát, chuẩn hóa việc xác nhận người bệnh trước khi cung cấp dịch vụ, lấy mẫu, thực hiện kỹ thuật và cấp phát thuốc.
- Hoàn thiện quy trình bàn giao giữa nhân viên, giữa khoa/phòng và khi chuyển người bệnh.
- Chuẩn hóa việc tiếp nhận, xác nhận và ghi nhận thông tin quan trọng, đặc biệt trong tình huống khẩn cấp và y lệnh miệng.

4.3. Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý

- Chuẩn hóa quy trình quản lý, kê đơn, cấp phát và sử dụng thuốc; chú trọng các nguy cơ phát sinh khi chuyển sang quy trình tích hợp robot.
- Kiểm soát thuốc dễ nhầm lẫn, thuốc nguy cơ cao và các bước kiểm tra trước bàn giao.
- Tăng cường dược lâm sàng, thông tin thuốc, tư vấn sử dụng và theo dõi phản ứng có hại của thuốc.

4.4. Bảo đảm an toàn phẫu thuật, thủ thuật

- Duy trì bảng kiểm an toàn; kiểm tra đúng người bệnh, đúng vị trí, đúng phương pháp và các điều kiện cần thiết trước thực hiện.
- Giám sát tuân thủ, phân tích tồn tại và triển khai biện pháp khắc phục.

4.5. Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn

- Bảo đảm phương tiện, vật tư và điều kiện thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn.
- Cập nhật quy trình, tập huấn và giám sát vệ sinh tay, phòng ngừa chuẩn, vệ sinh môi trường và các nội dung liên quan.
- Ứng dụng bảng kiểm điện tử và bảng tổng hợp kết quả để theo dõi, phản hồi và cải tiến.

4.6. Bảo đảm an toàn môi trường và trang thiết bị

- Rà soát nguy cơ trượt ngã, sàn ướt, chướng ngại vật, thiếu ánh sáng, mất an toàn điện, cháy nổ và sử dụng thiết bị.
- Bổ sung cảnh báo, phương tiện hỗ trợ và xử lý vị trí có nguy cơ.
- Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị và tập huấn xử lý tình huống theo kế hoạch.

Tổ chức thực hiện và kết quả đầu ra:

- **Chủ trì:** Tổ QLCL, KHTH.
- **Phối hợp:** Điều dưỡng, Khoa Dược, KSNK, TCHC, bộ phận trang thiết bị và các khoa lâm sàng, cận lâm sàng.
- **Tiến độ:** Thực hiện thường xuyên trong năm; đánh giá định kỳ và sau các sự cố cần phân tích.
- **Kết quả:** 100% nhân viên y tế được tập huấn, hướng dẫn; ≥95% nhân viên được đánh giá đạt sau tập huấn; 100% sự cố tiếp nhận được phân loại, xem xét và xử lý theo mức độ. Tăng ít nhất 10% số báo cáo tình huống suýt xảy ra sự cố hợp lệ so với

năm 2025; trường hợp số liệu nền bằng 0 hoặc chưa đầy đủ, xác lập chỉ tiêu phù hợp sau rà soát và trình phê duyệt.

5. Nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế

5.1. Khảo sát và sử dụng kết quả khảo sát để cải tiến

- Khảo sát người bệnh nội trú, ngoại trú, bà mẹ sau sinh và nhân viên y tế; phân tích riêng từng nhóm và từng nội dung cần cải thiện.
- Kết hợp hình thức điện tử và phiếu giấy, bảo đảm thuận tiện, khách quan và bảo mật.
- Chuẩn bị phiếu khảo sát, hướng dẫn song ngữ phù hợp để mở rộng tiếp nhận ý kiến người bệnh Campuchia.
- Tổng hợp phản ánh từ khảo sát, đường dây nóng, góp ý trực tiếp và Hội đồng người bệnh.
- Lựa chọn vấn đề ưu tiên; phân công người phụ trách, giải pháp và thời hạn; đánh giá lại sau can thiệp.

5.2. Nâng cao chất lượng giao tiếp và chăm sóc khách hàng

- Tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm về giao tiếp, hướng dẫn, tiếp nhận phản ánh và hỗ trợ người bệnh.
- Tăng cường hỗ trợ tại các điểm người bệnh thường gặp khó khăn trong hành trình khám.
- Thăm hỏi người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt; triển khai hoạt động công tác xã hội và hỗ trợ người bệnh khó khăn phù hợp với nguồn lực.

5.3. Cải thiện dịch vụ nội trú, dinh dưỡng và căn tin

- Rà soát tiện nghi buồng bệnh, vật dụng, vệ sinh và các dịch vụ hỗ trợ trong thời gian nằm viện.
- Thu thập ý kiến về thực đơn, khẩu vị, thời gian phục vụ, giá cả và chất lượng suất ăn.
- Phối hợp cải tiến thực đơn phù hợp nhu cầu dinh dưỡng, bệnh lý; giám sát an toàn thực phẩm, chất lượng phục vụ và niêm yết giá tại căn tin.
- Lựa chọn, triển khai và đánh giá các hoạt động cải tiến cụ thể.

Tổ chức thực hiện và kết quả đầu ra:

- **Chủ trì:** CTXH.
- **Phối hợp:** Điều dưỡng, TCHC, bộ phận dinh dưỡng, KSNK và các khoa, phòng.
- **Tiến độ:** Khảo sát người bệnh ít nhất mỗi quý; nhân viên ít nhất hai lần/năm; triển khai cải tiến xuyên suốt năm.
- **Kết quả:** Tỷ lệ hài lòng đạt ≥90% ở từng nhóm người bệnh nội trú, ngoại trú và nhân viên. 100% vấn đề ưu tiên có phương án xử lý; triển khai ít nhất một hoạt động cải tiến dịch vụ nội trú và một hoạt động cải tiến suất ăn hoặc căn tin, có đánh giá kết quả.

6. Hoàn thiện việc đo lường, giám sát và sử dụng chỉ số chất lượng để cải tiến

Nội dung hoạt động: Tổ QLCL rà soát lại các chỉ số chất lượng bệnh viện, tổ chức phân công thu thập số liệu định kỳ. Báo cáo chỉ số chất lượng theo dõi mỗi 6 tháng (Phụ lục 2).

- Rà soát, ban hành bộ chỉ số chất lượng ưu tiên, bám sát bảy mục tiêu và các đề án của bệnh viện.
- Quy định cho từng chỉ số: định nghĩa, cách tính, đối tượng, nguồn dữ liệu, phương pháp thu thập, tần suất báo cáo, người phụ trách và mức cần đạt.
- Thu thập số liệu nền trước can thiệp; thống nhất mốc bắt đầu, kết thúc khi đo thời gian khám bệnh và cấp phát thuốc.
- Theo dõi riêng các nhóm người bệnh có quy trình khác nhau và các thời điểm cao điểm để xác định đúng vấn đề.
- Ưu tiên khai thác dữ liệu từ phần mềm; kiểm tra tính đầy đủ, chính xác và đối chiếu thực tế khi cần.
- Báo cáo hằng tháng các chỉ số trọng tâm về thời gian khám, cấp phát thuốc và an toàn; các chỉ số khác theo tần suất được phê duyệt.
- Tổng hợp báo cáo sáu tháng và cuối năm; phân tích xu hướng, kết quả trước–sau và nguyên nhân chưa đạt.
- Sử dụng kết quả đo lường để điều chỉnh quy trình, nguồn lực và giải pháp cải tiến; phản hồi đến các đơn vị thực hiện.

Tổ chức thực hiện và kết quả đầu ra:

- **Chủ trì:** Tổ QLCL.
- **Phối hợp:** CNTT, KHTH và các khoa, phòng phụ trách chỉ số.
- **Tiến độ:** Ban hành bộ chỉ số trong quý I; thu thập, giám sát và báo cáo trong năm.
- **Kết quả:** 100% chỉ số có hướng dẫn đo lường và người phụ trách; 100% đề án CTCL được theo dõi tiến độ, đánh giá kết quả bằng chỉ số phù hợp. Danh mục và phương pháp đo lường được thể hiện tại Phụ lục 2.

7. Duy trì và nâng cao chất lượng toàn viện

7.1. Rà soát, duy trì và nâng cao mức đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí

- Rà soát kết quả đánh giá chất lượng năm 2025; xác định các tiêu chí còn hạn chế, nguy cơ giảm mức và nội dung cần ưu tiên cải tiến.
- Phân công đơn vị phụ trách từng tiêu chí, nội dung khắc phục, thời hạn và minh chứng cần hoàn thiện.
- Duy trì các nội dung đã đạt; cập nhật yêu cầu đánh giá và các hướng dẫn áp dụng.
- Gắn cải tiến tiêu chí với thay đổi thực tế trong hoạt động chuyên môn và phục vụ người bệnh.

7.2. Duy trì và cải tiến chất lượng xét nghiệm

- Tiếp tục triển khai quản lý chất lượng phòng xét nghiệm; tự đánh giá, xác định khoảng cách và xây dựng kế hoạch khắc phục.
- Duy trì nội kiểm, mở rộng ngoại kiểm lên 9 chương trình theo kế hoạch chuyên môn; phân tích kết quả và xử lý nội dung chưa đạt.
- Theo dõi các chỉ số chất lượng trước, trong và sau xét nghiệm.

- Phối hợp triển khai khu lấy máu tầng trệt với 5 bàn lấy máu và hệ thống vận chuyển mẫu bằng khí nén theo tiến độ được phê duyệt; đánh giá tính phù hợp của hệ thống vận chuyển đối với từng loại mẫu trước khi áp dụng thường quy.
- Triển khai ít nhất 2 xét nghiệm/kỹ thuật mới theo kế hoạch chuyên môn; bảo đảm nhân lực, thiết bị, quy trình và đánh giá chất lượng trước sử dụng.
- Rà soát, hoàn thiện điều kiện an toàn sinh học và đào tạo nhân viên.
- Đánh giá hiệu quả cải tiến lấy mẫu, vận chuyển và trả kết quả trong chương trình cải tiến ngoại trú tại mục 2.

7.3. Tổ chức đánh giá và theo dõi khắc phục

- Phân công nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục 3; theo dõi tiến độ tại Phụ lục 4 và kết quả đầu ra tại Phụ lục 5.
- Tự đánh giá chất lượng bệnh viện giữa năm và cuối năm; bảo đảm trung thực, khách quan, đầy đủ minh chứng.
- Tổng hợp các tồn tại, phân công khắc phục, kiểm tra việc hoàn thành và báo cáo Hội đồng QLCL.
- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch và các đề án; ghi nhận các đơn vị thực hiện hiệu quả, duy trì giải pháp thành công và xác định ưu tiên cho năm tiếp theo.

Tổ chức thực hiện và kết quả đầu ra:

- **Chủ trì:** Hội đồng QLCL.
- **Đầu mối:** Tổ QLCL; Khoa Xét nghiệm chủ trì nội dung chất lượng xét nghiệm.
- **Phối hợp:** Tất cả các khoa, phòng.
- **Tiến độ:** Rà soát, phân công trong quý I; tự đánh giá giữa năm và cuối năm; khắc phục thường xuyên.
- **Kết quả:** 100% tồn tại qua đánh giá có phân công khắc phục và thời hạn; duy trì đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cơ bản áp dụng; không có tiêu chí mức 1; phấn đấu điểm trung bình chất lượng bệnh viện ≥3,71 theo bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá áp dụng.

Kinh phí thực hiện các nội dung trên: Sử dụng nguồn kinh phí bệnh viện theo dự toán được phê duyệt. Các khoa, phòng lập dự toán cho từng đề án, hoạt động; các hạng mục robot, phần mềm, cải tạo cơ sở vật chất và thiết bị được tổng hợp theo kế hoạch đầu tư, bảo đảm thống nhất và không trùng lặp kinh phí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng quản lý chất lượng

- Tham mưu Ban Giám đốc phê duyệt kế hoạch, các đề án CTCL và dự toán kinh phí; đề xuất bố trí nguồn lực phù hợp với mục tiêu ưu tiên.
- Chỉ đạo phổ biến chính sách, mục tiêu và kế hoạch CTCL đến toàn bệnh viện.
- Điều phối các hoạt động cải tiến liên khoa, trọng tâm là hiện đại hóa quy trình khám bệnh ngoại trú và ứng dụng robot cấp phát thuốc.
- Họp định kỳ hằng quý để xem xét tiến độ, kết quả, khó khăn và đề xuất giải pháp; xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

- Xem xét kết quả đánh giá các đề án; đề xuất duy trì, nhân rộng giải pháp hiệu quả và ghi nhận, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

2. Các tiểu ban và mạng lưới quản lý chất lượng

- Các tiểu ban xây dựng kế hoạch hoạt động, kiểm tra và giám sát chuyên đề theo lĩnh vực được phân công; tổng hợp kết quả, kiến nghị và báo cáo về Tổ QLCL.
- Thành viên mạng lưới QLCL làm đầu mối tại khoa, phòng trong việc triển khai đề án, thu thập số liệu, theo dõi chỉ số và lưu trữ minh chứng.
- Phối hợp tự kiểm tra, đánh giá chất lượng giữa năm và cuối năm; xác định tồn tại, phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục.
- Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra, báo cáo kịp thời khó khăn vượt thẩm quyền giải quyết.

3. Tổ quản lý chất lượng

- Là đầu mối tham mưu Hội đồng QLCL xây dựng, cập nhật kế hoạch, mục tiêu và bộ chỉ số chất lượng bệnh viện.
- Hướng dẫn các khoa, phòng lựa chọn vấn đề ưu tiên, xây dựng đề án, xác định số liệu nền, chỉ tiêu, giải pháp và phương pháp đánh giá.
- Thống nhất biểu mẫu đăng ký đề án, báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả và hồ sơ minh chứng; tổng hợp đề án trình xem xét, phê duyệt.
- Theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện; tổng hợp báo cáo hằng tháng đối với chương trình cải tiến trọng tâm và báo cáo định kỳ theo kế hoạch.
- Phối hợp kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu; phân tích kết quả trước–sau và đề xuất điều chỉnh đối với các mục tiêu chưa đạt.
- Phối hợp với KHTH trong phân tích sự cố y khoa và giám sát hiệu quả các giải pháp khắc phục, phòng ngừa.
- Làm đầu mối tổ chức tự đánh giá chất lượng bệnh viện giữa năm, cuối năm và tổng kết hoạt động CTCL.

4. Phòng Kế hoạch tổng hợp

- Chủ trì phối hợp chuyên môn giữa các khoa, phòng; cùng Khoa Khám bệnh rà soát, chuẩn hóa quy trình khám bệnh ngoại trú và tiếp nhận người bệnh vào nội trú.
- Làm đầu mối rà soát, trình ban hành các quy trình, quy định và hướng dẫn chuyên môn theo thẩm quyền.
- Chủ trì đề án cải tiến hoạt động ghi nhận, báo cáo và phản hồi sự cố y khoa; phối hợp Tổ QLCL và các đơn vị liên quan phân tích nguyên nhân, triển khai và theo dõi biện pháp phòng ngừa.
- Phối hợp kiểm tra việc tuân thủ quy trình chuyên môn, khắc phục các tồn tại ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng điều trị.

5. Phòng Tổ chức hành chính

- Phối hợp kiện toàn tổ chức, phân công nhân sự và tổ chức đào tạo phục vụ hoạt động QLCL, CTCL.
- Chủ trì cải tiến công tác đón tiếp từ cổng, bố trí bãi đậu xe, phân luồng giao thông và giảm ùn tắc; chỉ đạo bộ phận bảo vệ hỗ trợ người bệnh cần ưu tiên.

- Phối hợp cải tạo không gian, biển chỉ dẫn, khu chờ và tiện ích; bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho các hạng mục được phê duyệt.
- Phối hợp KSNK và các đơn vị liên quan duy trì cảnh quan, vệ sinh môi trường, 5S và an toàn tại các khu vực phục vụ người bệnh.

6. Phòng Điều dưỡng

- Chủ trì chuẩn hóa việc bố trí, quản lý và sử dụng xe tiêm thuốc; hướng dẫn, giám sát thực hiện tại các khoa lâm sàng.
- Phối hợp chuẩn hóa nhận diện người bệnh, bàn giao, hướng dẫn, tư vấn và các quy trình chăm sóc.
- Tổ chức tập huấn, đánh giá năng lực và giám sát tuân thủ các nội dung thuộc phạm vi điều dưỡng.
- Phối hợp cải thiện chất lượng phục vụ nội trú, phòng ngừa té ngã và nâng cao trải nghiệm người bệnh.

7. Phòng Tài chính – Kế toán

- Tổng hợp, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch và các đề án theo dự toán được phê duyệt.
- Kiểm soát hồ sơ, hợp đồng và các khoản chi thuộc phạm vi phụ trách; hướng dẫn thủ tục thanh toán, quyết toán.
- Chủ trì mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, cải tiến quy trình thu phí, đối soát và xử lý giao dịch nhằm giảm thời gian chờ.
- Phối hợp đánh giá chi phí, hiệu quả sử dụng nguồn lực của các hạng mục cải tiến trọng tâm.

8. Các đơn vị chủ trì các hợp phần cải tiến trọng tâm

- **Khoa Khám bệnh:** Chủ trì tổ chức tiếp đón, phân luồng, điều phối phòng khám; phối hợp KHTH và các đơn vị liên quan cải tiến toàn bộ hành trình khám bệnh ngoại trú.
- **Khoa Dược:** Chủ trì triển khai quy trình cấp phát thuốc tích hợp robot; đào tạo nhân viên, tổ chức kiểm tra, bàn giao, tư vấn và phương án cấp phát dự phòng; theo dõi thời gian nhận thuốc và an toàn cấp phát.
- **Bộ phận CNTT:** Chủ trì cải tiến website; phối hợp triển khai đăng ký khám trực tuyến, thanh toán điện tử, kết nối dữ liệu và khai thác chỉ số; bảo đảm vận hành, phân quyền và bảo mật hệ thống.
- **Khoa Xét nghiệm, Khoa CĐHA – TDCN:** Chủ trì cải tiến tiếp nhận, điều phối, thực hiện kỹ thuật và trả kết quả; theo dõi thời gian chờ, tỷ lệ đúng hẹn và chất lượng chuyên môn.
- **Khoa KSNK, Tổ lao công:** Khoa KSNK hướng dẫn, giám sát chuyên môn vệ sinh; Tổ lao công trực tiếp thực hiện vệ sinh theo phân công, chú trọng khu khám bệnh, khu chờ và nhà vệ sinh.
- **Bộ phận CTXH:** Chủ trì khảo sát sự hài lòng, tiếp nhận phản ánh và cải tiến hướng dẫn, chăm sóc khách hàng; phối hợp Khoa Phụ sản nâng cao hiệu quả truyền thông, tư vấn dịch vụ phòng VIP.

- Xây dựng, triển khai đề án CTCL phù hợp với thực trạng và kế hoạch chung; các khoa nội trú lựa chọn vấn đề ưu tiên về an toàn người bệnh hoặc chất lượng chuyên môn.
- Thu thập số liệu nền, theo dõi chỉ số, đánh giá kết quả trước–sau và lưu trữ đầy đủ minh chứng.
- Báo cáo tiến độ, kết quả về Tổ QLCL đúng thời hạn; chủ động đề xuất giải pháp khi có khó khăn hoặc nguy cơ không đạt mục tiêu.
- Duy trì các cải tiến hiệu quả trong hoạt động thường quy; thực hiện các biện pháp khắc phục sau giám sát, đánh giá.

10. Chế độ phối hợp và báo cáo

- Các đơn vị tham gia chương trình cải tiến trọng tâm báo cáo tiến độ và chỉ số hằng tháng; các hoạt động khác báo cáo theo lịch được phê duyệt.
- Tổ QLCL tổng hợp, báo cáo lãnh đạo bệnh viện và trình Hội đồng QLCL xem xét hằng quý; tổ chức sơ kết giữa năm và tổng kết cuối năm.
- Những vướng mắc ảnh hưởng đến an toàn người bệnh, vận hành hệ thống hoặc tiến độ phải được báo cáo kịp thời để xử lý.
- Nội dung điều chỉnh mục tiêu, tiến độ hoặc kinh phí phải được trình xem xét, phê duyệt trước khi thực hiện.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Các Khoa/Phòng;
- Lưu: VT, Tổ QLCL.

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1600589438-C.T.T.N.H.H
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN
T.P CHÂU ĐỐC - T. AN GIANG

Châu Hữu Hầu

Phụ lục 1. DANH MỤC CÁC TIÊU CHÍ NÂNG MỨC CHẤT LƯỢNG NÂNG MỨC NĂM 2026

Tiêu chí	Nội dung	2025	2026	Giải pháp các tiểu mục	Trách nhiệm	Hồ sơ minh chứng / Kết quả đầu ra
C4.4	Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện	3	4	• Lập KH tập huấn KSNK cho toàn bộ NVYT. • Xây dựng quy trình mới và cập nhật quy trình cũ. • Tạo bảng kiểm đánh giá tuân thủ KSNK online dạng google form, thu thập dữ liệu NKBV từ phần mềm Viettel-His rồi liên kết Dashboard báo cáo.	K. KSNK	• KH và Biên bản tập huấn. • Xây dựng ít nhất 05 quy trình mới/cập nhật. • Dashboard trình bày trực quan số liệu giám sát KSNK & NKBV.
C6.3	Người bệnh được theo dõi, chăm sóc phù hợp với tình trạng bệnh và phân cấp chăm sóc	4	5	Tiến hành đánh giá công tác theo dõi, chăm sóc người bệnh; có báo cáo đánh giá trên phạm vi bệnh viện.	P. Điều dưỡng	Bảng kiểm theo dõi, chăm sóc người bệnh.
C9.1	Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược	3	4	Tăng cường đào tạo về dược cho toàn bộ nhân viên khoa.	K. Dược	Chứng nhận đào tạo liên tục.

Phụ lục 2. BẢNG PHÂN CÔNG THEO DÕI VÀ BÁO CÁO CSCL 2026

TT	Tên chỉ số	Khía cạnh	Thành tố	Mục tiêu	Khoa phòng theo dõi
1	Tỷ lệ thực hiện kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến khám chữa bệnh	Năng lực chuyên môn	Quá trình	> 50%	P. KHTH
2	Tỷ lệ kỹ thuật chuyên môn được phê duyệt và thực hiện trên tổng số kỹ thuật theo phân tuyến	Năng lực chuyên môn	Quá trình	> 90%	Mắt - LCK
3	Tỷ lệ cán bộ y tế được đào tạo, cập nhật chuyên môn theo quy định	Năng lực chuyên môn	Quá trình	> 50%	Mắt - LCK
4	Tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ	An toàn	Đầu ra	< 5%	K. KSNK
5	Số trường hợp báo cáo sự cố tự nguyện, bắt buộc	An toàn	Đầu ra	> 100 TH	P. KHTH
6	Tỷ lệ tuân thủ vệ sinh tay	An toàn	Quá trình	> 75%	K. KSNK
7	Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện	An toàn	Đầu ra	< 0,05%	K. KSNK
8	Tỷ lệ viêm mủ nội nhãn sau phẫu thuật nội nhãn	An toàn	Đầu ra	< 0,2%	Mắt - LCK
9	Tỷ lệ ca phẫu thuật sử dụng đúng hướng dẫn thực hiện bảng kiểm an toàn phẫu thuật	An toàn	Quá trình	> 99%	Mắt - LCK
10	Thời gian khám bệnh trung bình của người bệnh	Hiệu suất	Quá trình	< 75 phút	KKB
11	Thời gian phát thuốc ngoại trú trung bình	Hiệu suất	Quá trình	< 15 phút	K. Dược
12	Thời gian trả kết quả xét nghiệm trung bình	Hiệu suất	Quá trình	< 45 phút	K. XN
13	Công suất sử dụng giường bệnh thực tế	Hiệu suất	Đầu ra	> 75%	P. KHTH
14	Tỷ lệ hồ sơ bệnh án hoàn thiện các yêu cầu cơ bản theo quy chế HSBA	Hiệu quả	Đầu ra	> 99%	Mắt - LCK
15	Tỷ lệ người bệnh đạt thị lực tốt sau phẫu thuật đục thủy tinh thể đơn thuần	Hiệu quả	Đầu ra	> 85%	Mắt - LCK
16	Tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế	Hướng đến NVYT	Đầu ra	> 90%	P. TCHC
17	Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám chữa bệnh	Hướng đến người bệnh	Đầu ra	> 85%	P. CTXH

Phụ lục 3. BẢNG PHÂN CÔNG TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG (83 TIÊU CHÍ)

Tóm tắt phân công 83 tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện theo các Phần A, B, C, D, E:

Tiêu chí	Nội dung	Năm 2025	Năm 2027	Trách nhiệm thực hiện
A	PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)			
A1	A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)			
A1.1	Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể	5	5	P.TCHC
A1.2	Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật	3	3	K.KB
A1.3	Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh	4	4	K.KB
A1.4	Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời	4	4	K.HSCC
A1.5	Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên	4	4	K.KB
A.1.6	Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện	3	3	K.CLS
A2	A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5)			
A2.1	Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường	4	4	P.ĐD
A2.2	Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện	4	4	K.KSNK
A2.3	Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt	5	5	P.TCHC
A2.4	Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý	5	5	K.LCK
A2.5	Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện	4	4	K.LCK
A3	A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)			
A3.1	Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp	5	5	K.KSNK
A3.2	Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp	4	4	K.KSNK
A4	A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)			

A4.1	Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị	4	4	P.ĐD
A4.2	Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân	4	4	P.ĐD
A4.3	Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác	4	4	P.TCKT
A4.5	Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời	4	4	P.CTXH
A4.6	Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp	4	4	P.CTXH
B	PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)			
B1	B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)			
B1.1	Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện	4	4	P.TCHC
B1.2	Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện	2	2	P.TCHC
B1.3	Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện	3	3	P.TCHC
B2	B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)			
B2.1	Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp	3	3	P.TCHC
B2.2	Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức	4	4	P.TCHC
B2.3	Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực	4	4	P.TCHC
B3	B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4)			
B3.1	Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế	4	4	P.TCHC
B3.2	Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế	4	4	P.TCHC
B3.3	Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện	4	4	P.TCHC
B3.4	Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế	4	4	P.TCHC
B4	B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)			
B4.1	Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai	3	3	P.TCHC
B4.2	Triển khai văn bản của các cấp quản lý	4	4	P.TCHC
B4.3	Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện	3	3	P.TCHC
B4.4	Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận	3	3	P.TCHC

C	PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)			
C1	C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)			
C1.1	Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện	4	4	P.TCHC
C1.2	Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ	3	3	P.TCHC
C2	C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)			
C2.1	Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học	4	4	P.KHTH
C2.2	Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học	4	4	P.KHTH
C3	C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2) (điểm x2)			
C3.1	Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế	4	4	P.CNTT
C3.2	Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn	4	4	P.CNTT
C4	C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)			
C4.1	Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn	4	4	K.KSNK
C4.2	Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện	4	4	K.KSNK
C4.3	Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay	4	4	K.KSNK
C4.4	Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện	3	**4**	K.KSNK
C5	C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (5) (điểm x2)			
C5.2	Nghiên cứu và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới	3	3	P.KHTH
C5.3	Áp dụng các hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng	3	3	P.KHTH
C5.4	Xây dựng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị	3	3	P.KHTH
C5.5	Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đã ban hành và giám sát việc thực hiện	3	3	P.KHTH
C6	C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (3)			
C6.1	Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả	4	4	P.ĐD

C6.2	Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị	4	4	P.ĐD
C6.3	Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện	4	**5**	P.ĐD
C7	C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5)			
C7.1	Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện	3	3	K.DD
C7.2	Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện	5	5	K.DD
C7.3	Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện	5	5	K.DD
C7.4	Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý	4	4	K.DD
C7.5	Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện	4	4	K.DD
C8	C8. Chất lượng xét nghiệm (2)			
C8.1	Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh	3	3	K.XN
C8.2	Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm	3	3	K.XN
C9	C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)			
C9.1	Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược	3	**4**	Dược
C9.2	Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược	3	3	Dược
C9.3	Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng	4	4	Dược
C9.4	Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý	3	3	Dược
C9.5	Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) kịp thời, đầy đủ và có chất lượng	3	3	Dược
C9.6	Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả	3	3	Dược
C10	C10. Nghiên cứu khoa học (2)			
C10.1	Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học	3	3	P.KHTH
C10.2	Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh	3	3	P.KHTH
D	PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (12)			
D1	D1. Thiết lập hệ thống và cải tiến chất lượng (3)			
D1.1	Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện	5	5	Tổ. QLCL

D1.2	Xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện	4	4	Tổ. QLCL
D1.3	Xây dựng văn hóa chất lượng	4	4	Tổ. QLCL
D2	D2. Phòng ngừa các sự cố khắc phục (5)			
D2.1	Phòng ngừa nguy cơ, diễn biến bất thường xảy ra với người bệnh	4	4	K.HSCC
D2.2	Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích sự cố y khoa và tiến hành các giải pháp khắc phục	4	4	Tổ. QLCL
D2.3	Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố y khoa	4	4	PT-GMHS
D2.4	Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ	4	4	P.ĐD
D2.5	Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã	4	4	Tổ. QLCL
D3	D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (3)			
D3.1	Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện	5	5	Tổ. QLCL
D3.2	Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện	4	4	Tổ. QLCL
D3.3	Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện	4	4	Tổ. QLCL
E	PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA (4)			
E1	E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (4)			
E1.1	Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh	2	2	K.Sản
E1.2	Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong sinh và sau sinh	4	4	K.Sản
E1.3	Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của BYT và UNICEF	4	4	K.Sản
E2.1	Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc Nhi khoa	2	2	K.Nhi

Phụ lục 4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Thời gian cần thiết	Thời gian bắt đầu	CV cần hoàn thành trước	Thời gian thực hiện (tháng)												Số lần thực hiện
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Kiểm tra và điều chỉnh biển hiệu BV, bảng giá giữ xe và giá tiền trông xe, biển báo chỉ dẫn, sơ buồng bệnh, sơ đồ bệnh viện, sơ đồ khoa, nhận diện thương hiệu trên các biểu mẫu									x				x			2 lần/năm
2	Khảo sát các vị trí, tính toán nhu cầu, tình trạng ghế chờ tại những nơi người bệnh và người nhà người bệnh phải chờ đợi									x				x			2 lần/năm
3	Lập cam kết và công khai các cam kết về thời gian chờ đợi tối đa cho một hoạt động liên quan đến khám bệnh									x				x			2 lần/năm
4	Đánh giá định kỳ thời gian chờ đợi của người bệnh và phát hiện được các vấn đề cần cải tiến						x			x			x			x	1 lần/quý
5	Công khai biểu đồ theo dõi thời gian chờ đợi và khám bệnh cho các đối tượng người bệnh tại khu khám bệnh				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mỗi tháng
6	Đánh giá hoạt động cấp cứu (ưu nhược điểm, các vấn đề còn tồn tại), theo dõi kết quả cấp cứu người bệnh theo thời gian như thành công, tử vong, biến chứng, chuyển tuyến,..						x			x			x			x	1 quý/lần
7	Học tập, rút kinh nghiệm từ các kết quả đánh giá cấp cứu				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Bình bệnh án
8	Kiểm tra, làm vệ sinh toàn bộ nhà vệ sinh của BV: nước đọng, mùi hôi, xà phòng, quạt thông gió, vòi nước và ghi vào nhật ký vệ sinh				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mỗi ngày
9	Kiểm tra, dự trù, thay mới chăn, ga, gối, nệm,													x			1 lần/năm

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Thời gian cần thiết	Thời gian bắt đầu	CV cần hoàn thành trước	Thời gian thực hiện (tháng)												Số lần thực hiện
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	quần áo bệnh nhân, áo choàng, ghế ngồi cho người chăm sóc																
10	Sửa chữa đèn, máy điều hòa, quạt, vòi nước, mạng internet khi bị hư hỏng				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mỗi ngày
11	Kiểm tra giá niêm yết của các cửa hàng tiện lợi trong BV (giá của 20 mặt hàng bán chạy nhất không cao hơn giá siêu thị bên ngoài bệnh viện quá 10%)													x			1 lần/năm
12	Vệ sinh ngoại cảnh BV, chăm sóc cây xanh				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Mỗi ngày
13	Giới thiệu và tập huấn 5S cho NVYT						x										1 lần/năm
14	Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa lại định kỳ "Phiếu tóm tắt thông tin điều trị" hoặc khi hướng dẫn chẩn đoán và điều trị thay đổi													x			1 lần/năm
15	Có vách ngăn hoặc rèm che di động tại khoa lâm sàng									x						x	2 lần/năm
16	Cập nhật và đăng tải thông tin về giá dịch vụ y tế, giá thuốc, vật tư… trên trang thông tin điện tử của bệnh viện									x						x	6 tháng/lần hoặc khi có thay đổi
17	Tiếp nhận đường dây nóng, phân tích và chia nhóm các vấn đề khách hàng phàn nàn, thắc mắc/khen ngợi để có giải pháp xử lý hoặc xác định vấn đề ưu tiên cải tiến				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Hàng ngày
18	- Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của NB - Khảo sát và phân tích sự hài lòng của bệnh nhân						x			x			x			x	Quý/lần

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Thời gian cần thiết	Thời gian bắt đầu	CV cần hoàn thành trước	Thời gian thực hiện (tháng)												Số lần thực hiện
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	nội trú, ngoại trú - Lập danh sách các vấn đề ưu tiên cần giải quyết																
19	Các ý kiến của người bệnh được chuyển đến các cá nhân, bộ phận có liên quan và được phản hồi hoặc giải quyết kịp thời				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Hàng ngày
20	- Lập kế hoạch CTCL dựa trên vấn đề ưu tiên cần giải quyết - Họp nội bộ với những khoa lâm sàng có tỷ lệ hài lòng thấp nhất để bàn giải pháp CTCL				x												1 lần/năm
21	Báo cáo phân tích "nguyên nhân gốc rễ" các vấn đề người bệnh thường phàn nàn, thắc mắc														x		1 lần/năm
22	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ"						x			x			x			x	Quý/lần
23	Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực y tế và tiến hành đánh giá việc thực hiện kế hoạch					x											1 lần/năm
24	Thống kê các chỉ số liên quan đến số lượng nhân lực và theo dõi, cập nhật tình hình nhân lực các khoa lâm sàng và cận lâm sàng									x					x		6 tháng/lần
25	Cập nhật bảng mô tả công việc của các chức danh nghề nghiệp									x					x		2 lần/năm hoặc khi cần
26	Xây dựng đề án vị trí việc làm					x											1 lần/năm
27	Xây dựng kế hoạch đào tạo cho NVYT ngắn hạn và dài hạn				x												1 lần/năm

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Thời gian cần thiết	Thời gian bắt đầu	CV cần hoàn thành trước	Thời gian thực hiện (tháng)												Số lần thực hiện
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	Tổ chức kiểm tra tay nghề, chuyên môn												x				1 lần/năm
29	Xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức cho NVYT				x												1 lần/năm
30	Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức tại bệnh viện cho NVYT						x										1 lần/năm
31	Tổ chức các cuộc thi, phong trào, cam kết thi đua, kịch, hội diễn văn nghệ… để nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức cho NVYT				x												1 lần/năm
32	Tập huấn vệ sinh an toàn lao động									x							1 lần/năm
33	Khảo sát sự hài lòng của NVYT và báo cáo kết quả									x					x		6 tháng/lần
34	Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn bộ nhân viên bệnh viện và khám bệnh nghề nghiệp cho các NVYT										x						1 lần/năm
35	Lưu trữ đầy đủ hồ sơ sức khỏe của toàn thể NVYT (bản giấy hoặc trên phần mềm máy tính)											x					1 lần/năm
36	- Tiếp nhận và cập nhật các văn bản có liên quan đến hoạt động bệnh viện - Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện và rà soát định kỳ tiến độ triển khai				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Hàng ngày
37	Tập huấn phòng cháy, chữa cháy													x			1 lần/năm
38	Kiểm tra, quản lý HSBA				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Hàng ngày
39	Hoàn thiện hệ thống phần mềm bệnh viện: xây dựng chỉ số theo dõi hoạt động và chất lượng BV, kết xuất dữ liệu đầy đủ các tính năng theo yêu cầu				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Thời gian cần thiết	Thời gian bắt đầu	CV cần hoàn thành trước	Thời gian thực hiện (tháng)												Số lần thực hiện
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	của bộ tiêu chí																
40	Hoàn thành bệnh án điện tử				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
41	Họp hội đồng KSNK						x			x			x			x	1 quý/lần
42	Phát động phong trào vệ sinh tay							x									1 lần/năm
43	Giám sát hoạt động vệ sinh tay ở các khoa LS						x			x			x			x	1 quý/lần
44	Công bố kết quả khảo sát, đánh giá về việc thực hiện vệ sinh tay của nhân viên các khoa/phòng trong bệnh viện và đề xuất giải pháp can thiệp						x			x			x			x	1 quý/lần
45	Đánh giá tuân thủ vệ sinh tay, thống kê NKBV						x			x			x			x	1 quý/lần
46	Tập huấn vệ sinh tay, phân loại rác							x									1 lần/năm
47	Đánh giá chỉ tiêu môi trường về nước thải bệnh viện						x			x			x			x	1 quý/lần
48	Nuôi cấy vi khuẩn trong nước tại một số vị trí trọng điểm						x			x			x			x	1 quý/lần
49	Giám sát khoa trọng điểm, nhóm người bệnh trọng điểm/ các đối tượng có nguy cơ nhiễm khuẩn cao như người bệnh thở máy, người bệnh phẫu thuật						x			x			x			x	1 quý/lần
50	Kiểm tra và thay mới các tờ hướng dẫn rửa tay, phân loại rác,…													x			1 lần/năm
51	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải													x			1 lần/năm
52	Triển khai kỹ thuật mới				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Thường xuyên
53	Xây mới, cập nhật phác đồ điều trị				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Thường xuyên

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Thời gian cần thiết	Thời gian bắt đầu	CV cần hoàn thành trước	Thời gian thực hiện (tháng)												Số lần thực hiện
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
54	Bình bệnh án, bình đơn thuốc				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 lần/tháng
55	Bệnh viện tiến hành giám sát tuân thủ toàn bộ các hướng dẫn/ phác đồ điều trị của bệnh viện đã xây dựng được				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 lần/tháng hoặc đột xuất
56	Hội đồng điều dưỡng rà soát, cập nhật, bổ sung các quy định, quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh và duy trì sinh hoạt định kỳ													x			1 lần/năm
57	Tập huấn kỹ năng truyền thông, giáo dục sức khỏe cho NVYT													x			1 lần/năm
58	Tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân nội trú				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 lần/tháng
59	Thiết kế tờ rơi/ pa-nô/ áp-phích/ hình ảnh/ băng hình... phục vụ cho công tác hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, GDSK cho người bệnh đang được điều trị				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Thường xuyên
60	Xây dựng phiếu tóm tắt thông tin điều trị; rà soát, cập nhật định kỳ hoặc khi hướng dẫn chẩn đoán và điều trị thay đổi													x			1 lần/năm
61	Tổ chức thi tay nghề điều dưỡng									x							1 lần/năm
62	Họp hội đồng người bệnh				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 lần/tháng
63	Kiểm tra phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Thường xuyên
64	Truyền thông, giáo dục về dinh dưỡng ở các khoa lâm sàng hoặc họp hội đồng người bệnh				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 lần/tháng

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Thời gian cần thiết	Thời gian bắt đầu	CV cần hoàn thành trước	Thời gian thực hiện (tháng)												Số lần thực hiện
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
65	Kiểm tra, quản lý an toàn thực phẩm ở căn tin				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 lần/tháng
66	Nội kiểm khoa Xét nghiệm				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Hàng ngày
67	Ngoại kiểm khoa Xét nghiệm				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 lần/tháng
68	Tự đánh giá Bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng XN y học, hoàn thiện các nội dung để đạt mức 4									x						x	6 tháng/lần
69	Hướng dẫn sử dụng thuốc cho điều dưỡng, NVYT																Ít nhất 1 lần/năm
70	Tổ chức hoạt động thông tin thuốc cho bác sĩ, điều dưỡng				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Thường xuyên
71	Họp hội đồng thuốc				x		x		x		x		x		x		2 tháng/lần
72	Giám sát, báo cáo, tổng kết ADR														x		1 lần/năm
73	Kiểm tra cơ số tủ trực				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 lần/tháng
74	Xây dựng danh mục thuốc LASA														x		1 lần/năm
75	Khoa Dược báo cáo thường xuyên các số liệu về sử dụng thuốc				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 lần/tháng
76	Sinh hoạt khoa học định kỳ				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 lần/tháng
77	Xây dựng, trình duyệt và phổ biến kế hoạch CTCL chung toàn viện				x												Đầu năm

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Thời gian cần thiết	Thời gian bắt đầu	CV cần hoàn thành trước	Thời gian thực hiện (tháng)												Số lần thực hiện
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
78	Họp hội đồng QLCL						x			x			x			x	1 quý/lần
79	Hướng dẫn khoa/phòng làm đề án CTCL				x	x	x										
80	Tự đánh giá chất lượng bệnh viện, đăng báo cáo lên trang web, phổ biến kết quả cho NVYT và gửi kết quả cho Sở Y tế									x						x	6 tháng/lần
81	Nhận, gửi, lưu trữ công văn, báo cáo liên quan đến hoạt động QLCL				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Thường xuyên
82	Đánh giá, khen thưởng CTCL														x		Cuối năm
83	Khoa/phòng xây dựng mục tiêu chất lượng				x	x	x										Đầu năm
84	Quản lý sự cố y khoa				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Thường xuyên
85	Tổng hợp, phân tích sự cố y khoa						x			x			x			x	Quý và năm
86	Xây dựng, tổng hợp chỉ số chất lượng						x			x			x			x	1 quý/lần
87	Tiến hành rà soát và đánh giá dựa trên bảng kiểm việc thực hiện phòng ngừa các nguy cơ, diễn biến xấu xảy ra với người bệnh tại các khu vực có nguy cơ cao hoặc đã xảy ra các sự cố									x						x	6 tháng/lần
88	Kiểm tra việc tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Định kỳ và đột xuất
89	Tự đánh giá và hoàn thành các tiêu chí của Bộ tiêu chí an toàn phẫu thuật, tối thiểu đạt mức 3									x						x	6 tháng/lần
90	Rà soát tổng thể và lập danh sách các vị trí có nguy cơ trượt ngã và tiến hành xử lý												x				1 lần/năm

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Thời gian cần thiết	Thời gian bắt đầu	CV cần hoàn thành trước	Thời gian thực hiện (tháng)												Số lần thực hiện
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
91	Tổ chức lớp học tiền sản				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 lần/tháng
92	Thống kê, thực hiện chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh sanh thường, sanh mổ (BSMHT, da kề da, mẹ nằm cùng con, tư vấn NCBSM, chăm sóc thiết yếu)						x			x			x			x	1 lần/quý

Phụ lục 5. BẢNG KIỂM CÁC HOẠT ĐỘNG THEO KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NĂM 2026
THÁNG……./NĂM 2026

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Phụ trách	Phối hợp	Giám sát	Chỉ tiêu đánh giá	Kết quả đạt được			Ghi chú
						Đạt	Chưa đạt	Không thực hiện	
1	Kiểm tra và điều chỉnh biển hiệu BV, bảng giá giữ xe và giá tiền trông xe, biển báo chỉ dẫn, số buồng bệnh, sơ đồ bệnh viện, sơ đồ khoa, nhận diện thương hiệu trên các biểu mẫu	H. Luận	T.Bảo vệ T. Em	H. Luận	Có dán mới				
2	Khảo sát các vị trí, tính toán nhu cầu, tình trạng ghế chờ tại những nơi người bệnh và người nhà người bệnh phải chờ đợi	CN. Dung	P.TCHC	CN. Dung	Có báo cáo khảo sát				
3	Lập cam kết và công khai các cam kết về thời gian chờ đợi tối đa cho một hoạt động liên quan đến khám bệnh	CN. Dung		CN. Dung	Cam kết được niêm yết				
4	Đánh giá định kỳ thời gian chờ đợi của người bệnh và phát hiện được các vấn đề cần cải tiến	CN. Dung	P.CNTT	CN. Dung	Có kết quả thời gian chờ				
5	Công khai biểu đồ theo dõi thời gian chờ đợi và khám bệnh cho các đối tượng người bệnh tại khu khám bệnh	CN. Dung	P.CNTT	CN. Dung	Có biểu đồ dán tại KKB				
6	Đánh giá hoạt động cấp cứu (ưu nhược điểm, các vấn đề còn tồn tại), theo dõi kết quả cấp cứu người bệnh theo thời gian như thành công, tử vong, biến chứng, chuyển tuyến,..	BS. Tài	P.KHTH	BS. Tài	Có sổ theo dõi Có báo cáo đánh giá				
7	Học tập, rút kinh nghiệm từ các kết quả đánh giá cấp cứu	BS. Tài	P.KHTH	BS. Tài	Có BBA cấp cứu				
8	Kiểm tra, làm vệ sinh toàn bộ nhà vệ sinh của BV: nước đọng, mùi hôi, xà phòng, quạt thông gió, vòi nước và ghi vào nhật ký vệ sinh	HL. Hằng	Tổ y công	CN. Phương	Có sổ theo dõi				
9	Kiểm tra, dự trù, thay mới chăn, ga, gối, nệm, quần áo bệnh nhân, áo choàng, ghế ngồi cho người chăm sóc	ĐDT các khoa	P. TCHC	CN. Phương	Có phiếu dự trù, báo cáo				
10	Sửa chữa đèn, máy điều hòa, quạt, vòi nước, mạng internet	Tổ sửa	Các khoa	KS.	Có báo cáo				

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Phụ trách	Phối hợp	Giám sát	Chỉ tiêu đánh giá	Kết quả đạt được			Ghi chú
						Đạt	Chưa đạt	Không thực hiện	
	khi bị hư hỏng	chữa	phòng	Tâm					
11	Kiểm tra giá niêm yết của các cửa hàng tiện lợi trong BV (giá của 20 mặt hàng bán chạy nhất không cao hơn giá siêu thị bên ngoài bệnh viện quá 10%)	H. Luận		CN. Tú (KKB)	Có bảng so sánh giá				
12	Vệ sinh ngoại cảnh BV, chăm sóc cây xanh	H. Lộc	Tổ Bảo vệ	H. Luận	Có báo cáo				
13	Giới thiệu và tập huấn 5S cho NVYT	Ban 5S	Tổ QLCL	T. Em	Có kế hoạch				
14	Rà soát, cập nhật, chỉnh sửa lại định kỳ "Phiếu tóm tắt thông tin điều trị" hoặc khi hướng dẫn chẩn đoán và điều trị thay đổi	P. Điều dưỡng	Các khoa LS	Hồng Thái	Có kế hoạch				
15	Có vách ngăn hoặc rèm che di động tại khoa lâm sàng	P. Điều dưỡng	P. TCHC	Hồng Thái	Có báo cáo				
16	Cập nhật và đăng tải thông tin về giá dịch vụ y tế, giá thuốc, vật tư… trên trang thông tin điện tử của bệnh viện	P. TCKT	P. CNTT	CN. Vân	Có bài đăng trên trang web				
17	Tiếp nhận đường dây nóng, phân tích và chia nhóm các vấn đề khách hàng phàn nàn, thắc mắc/ khen ngợi để có giải pháp xử lý hoặc xác định vấn đề ưu tiên cải tiến	CN. Khánh	Tất cả khoa phòng	CN. Khánh	Có báo cáo quý				
18	- Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của người bệnh - Khảo sát và phân tích sự hài lòng của bệnh nhân nội trú, ngoại trú - Lập danh sách các vấn đề ưu tiên cần giải quyết	CN. Khánh		CN. Khánh	Có báo cáo quý				
19	Các ý kiến của người bệnh được chuyển đến các cá nhân, bộ phận có liên quan và được phản hồi hoặc giải quyết kịp thời	CN. Khánh	Tất cả khoa phòng	CN. Khánh	Có báo cáo quý				
20	- Lập kế hoạch CTCL dựa trên vấn đề ưu tiên cần giải quyết - Họp nội bộ với những khoa lâm sàng có tỷ lệ hài lòng thấp	CN. Khánh	Các khoa LS	CN. Khánh	Có kế hoạch và biên bản họp				

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Phụ trách	Phối hợp	Giám sát	Chỉ tiêu đánh giá	Kết quả đạt được			Ghi chú
						Đạt	Chưa đạt	Không thực hiện	
	nhất để bàn giải pháp cải tiến chất lượng								
21	Báo cáo phân tích "nguyên nhân gốc rễ" các vấn đề người bệnh thường phàn nàn, thắc mắc	CN. Khánh		CN. Khánh	Có báo cáo quý				
22	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ"	CN. Khánh	P.TCHC P. TCKT Tổ QLCL K.KSNK	CN. Hương	Có báo cáo quý				
23	Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực y tế và tiến hành đánh giá việc thực hiện kế hoạch	CN. Hương		CN. Hương	Có kế hoạch				
24	Thống kê các chỉ số liên quan đến số lượng nhân lực và theo dõi, cập nhật tình hình nhân lực các khoa lâm sàng và cận lâm sàng	P.TCHC		CN. Hương	Có bộ chỉ số				
25	Cập nhật bảng mô tả công việc của các chức danh nghề nghiệp	P.TCHC		CN. Hương	Có bảng mô tả				
26	Xây dựng đề án vị trí việc làm	P. TCHC		CN. Hương	Có đề án				
27	Xây dựng kế hoạch đào tạo cho NVYT ngắn hạn và dài hạn	P. TCHC		CN. Hương	Có kế hoạch				
28	Tổ chức kiểm tra tay nghề, chuyên môn	P. TCHC	P.KHTH	CN. Hương	Có kế hoạch				
29	Xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức cho NVYT	CN. Khánh	P.TCHC	CN. Hương	Có kế hoạch				
30	Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức tại bệnh viện cho NVYT	CN. Khánh	P.TCHC	CN. Hương	Có kế hoạch				

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Phụ trách	Phối hợp	Giám sát	Chỉ tiêu đánh giá	Kết quả đạt được			Ghi chú
						Đạt	Chưa đạt	Không thực hiện	
31	Tổ chức các cuộc thi, phong trào, cam kết thi đua, kịch, hội diễn văn nghệ… để nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức cho NVYT	CN. Khánh	P.TCHC	CN. Hương	Có kế hoạch				
32	Tập huấn vệ sinh an toàn lao động	P.TCHC		CN. Hương	Có kế hoạch và danh sách tham gia				
33	Khảo sát sự hài lòng của NVYT và báo cáo kết quả	P.TCHC		CN. Tuyền	Có báo cáo 6 tháng				
34	Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn bộ nhân viên bệnh viện và khám bệnh nghề nghiệp cho các NVYT	P.TCHC	P.KHTH	CN. Hương	Có kế hoạch				
35	Lưu trữ đầy đủ hồ sơ sức khỏe của toàn thể NVYT (bản giấy hoặc trên phần mềm máy tính)	P.TCHC	P.CNTT	CN. Hương	Có lưu trữ hồ sơ sức khỏe				
36	- Tiếp nhận và cập nhật các văn bản có liên quan đến hoạt động bệnh viện - Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo dành cho bệnh viện và rà soát định kỳ tiến độ triển khai	P.TCHC	P.KHTH	CN. Hương	Có sổ theo dõi				
37	Tập huấn phòng cháy, chữa cháy	P.TCHC		H. Luận	Có kế hoạch				
38	Kiểm tra, quản lý HSBA	T. Hải		BS. Tâm	100% HSBA được kiểm tra ngẫu nhiên đúng quy định				
39	Hoàn thiện hệ thống phần mềm bệnh viện: xây dựng chỉ số theo dõi, kết xuất dữ liệu đầy đủ các tính năng theo yêu cầu của Bộ tiêu chí	P. CNTT	Các khoa phòng	CN. An	Phần mềm có đầy đủ tính năng				
40	Hoàn thành bệnh án điện tử	P. KHTH	P.CNTT	BS. Tâm	Có BA điện tử				

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Phụ trách	Phối hợp	Giám sát	Chỉ tiêu đánh giá	Kết quả đạt được			Ghi chú
						Đạt	Chưa đạt	Không thực hiện	
41	Họp hội đồng KSNK	CN. Phương		CN. Phương	Có biên bản họp				
42	Phát động phong trào vệ sinh tay	CN. Phương		CN. Phương	Có kế hoạch				
43	Giám sát hoạt động vệ sinh tay ở các khoa LS	CN. Phương		CN. Phương	Có báo cáo quý				
44	Công bố kết quả khảo sát, đánh giá về việc thực hiện vệ sinh tay của nhân viên các khoa/phòng trong bệnh viện và đề xuất giải pháp can thiệp	CN. Phương		CN. Phương	Có báo cáo				
45	Thống kê nhiễm khuẩn bệnh viện	CN. Phương		CN. Phương	Có báo cáo				
46	Tập huấn vệ sinh tay, phân loại rác	CN. Phương	Các khoa	CN. Phương	Có kế hoạch				
47	Đánh giá chỉ tiêu môi trường về chất thải bệnh viện	CN. Phương	P.TCHC	CN. Phương	Có kết quả của cơ quan quan trắc				
48	Nuôi cấy vi khuẩn trong nước tại một số vị trí trọng điểm	CN. Phương	Khoa XN	CN. Phương	Có kết quả nuôi cấy				
49	Giám sát khoa trọng điểm, nhóm người bệnh trọng điểm/ các đối tượng có nguy cơ nhiễm khuẩn cao như người bệnh thở máy, người bệnh phẫu thuật	CN. Phương		CN. Phương	Có số liệu báo cáo				
50	Kiểm tra và thay mới các tờ hướng dẫn rửa tay, phân loại rác,…	CN. Phương	K. KSNK	CN. Phương	Toàn bộ các bồn rửa tay, thùng rác đều có dán				
51	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý chất thải	CN.		CN.	Có văn bản				

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Phụ trách	Phối hợp	Giám sát	Chỉ tiêu đánh giá	Kết quả đạt được			Ghi chú
						Đạt	Chưa đạt	Không thực hiện	
		Phương		Phương					
52	Triển khai kỹ thuật mới	P. KHTH	Các khoa	BS. Tâm	Có danh sách				
53	Xây mới, cập nhật phác đồ điều trị	P. KHTH	Các khoa LS	BS. Tâm	Có kế hoạch và phác đồ mới được phê duyệt				
54	Bình bệnh án, bình đơn thuốc	P.KHTH	Các khoa LS, khoa Dược	BS. Tâm	Có danh sách NV tham gia				
55	Bệnh viện tiến hành giám sát tuân thủ toàn bộ các hướng dẫn/phác đồ điều trị của bệnh viện đã xây dựng được	P.KHTH	Các khoa LS	BS. Tâm	Có văn bản giám sát				
56	Hội đồng điều dưỡng rà soát, cập nhật, bổ sung các quy định, quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh và duy trì sinh hoạt định kỳ	P. Điều dưỡng	Các khoa LS	H. Thái	Có quy định, quy trình mới được phê duyệt				
57	Tập huấn kỹ năng truyền thông, giáo dục sức khỏe cho NVYT	P. Điều dưỡng	Các khoa	H. Thái	Có kế hoạch				
58	Tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân nội trú	P. Điều dưỡng	Các khoa LS	H. Thái	Có sổ theo dõi				
59	Thiết kế tờ rơi/ pa-nô/ áp-phích/ hình ảnh/ băng hình... phục vụ cho công tác hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, GDSK cho người bệnh đang được điều trị	P. Điều dưỡng	Các khoa LS	H. Thái	Có phương tiện truyền thông ở các khoa				
60	Xây dựng phiếu tóm tắt thông tin điều trị; rà soát, cập nhật định kỳ hoặc khi hướng dẫn chẩn đoán và điều trị thay đổi	P. Điều dưỡng	Các khoa LS	H. Thái	Có phiếu tóm tắt được phê duyệt				
61	Tổ chức thi tay nghề điều dưỡng	P. Điều dưỡng	Các khoa LS,	H. Thái	Có kế hoạch				

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Phụ trách	Phối hợp	Giám sát	Chỉ tiêu đánh giá	Kết quả đạt được			Ghi chú
						Đạt	Chưa đạt	Không thực hiện	
			P.TCHC						
62	Họp hội đồng người bệnh	P. Điều dưỡng	Các khoa LS	H. Thái	Có biên bản				
63	Kiểm tra phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng	K. DD	Các khoa LS	BS. Nguyệt	Có báo cáo				
64	Truyền thông, giáo dục về dinh dưỡng ở các khoa lâm sàng hoặc họp hội đồng người bệnh	K. DD	Các khoa LS	BS. Nguyệt	Có sổ theo dõi				
65	Kiểm tra, quản lý an toàn thực phẩm ở căn tin	K. DD		BS. Nguyệt	Có biên bản				
66	Nội kiểm khoa Xét nghiệm	K. XN		CN. Thanh	Có sổ theo dõi				
67	Ngoại kiểm khoa Xét nghiệm	K. XN		CN. Thanh	Có văn bản				
68	Tự đánh giá bộ tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng XN y học, hoàn thiện các yêu cầu để đạt mức 4	K. XN	Tổ QLCL	CN. Thanh	Có biên bản				
69	Hướng dẫn sử dụng thuốc cho điều dưỡng, NVYT	Dược		DS. Thi	Có văn bản				
70	Tổ chức hoạt động thông tin thuốc cho bác sĩ, điều dưỡng	Dược		DS. Thi	Có văn bản				
71	Họp hội đồng thuốc	Dược		DS. Thi	Có biên bản				
72	Giám sát, báo cáo, tổng kết ADR	Dược	Các khoa	DS. Thi	Có báo cáo				
73	Kiểm tra cơ số tủ trực	Dược	Các khoa	DS. Thi	Có báo cáo				
74	Xây dựng danh mục thuốc LASA	Dược		DS. Thi	Có danh mục được phê duyệt				
75	Khoa dược báo cáo thường xuyên các số liệu về sử dụng thuốc	Dược		DS. Thi	Có báo cáo				
76	Sinh hoạt khoa học định kỳ	P.KHTH		BS. Tâm	Có kế hoạch				

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Phụ trách	Phối hợp	Giám sát	Chỉ tiêu đánh giá	Kết quả đạt được			Ghi chú
						Đạt	Chưa đạt	Không thực hiện	
77	Xây dựng, trình duyệt và phổ biến kế hoạch CTCL chung toàn viện	Tổ QLCL		DS. Thư	Có kế hoạch được phê duyệt				
78	Họp hội đồng QLCL	Tổ QLCL		DS. Thư	Có biên bản				
79	Hướng dẫn khoa/phòng làm đề án CTCL	Tổ QLCL		DS. Thư	Có tài liệu hướng dẫn				
80	Tự đánh giá chất lượng bệnh viện, đăng báo cáo lên trang web, phổ biến kết quả cho NVYT và gửi kết quả cho Sở Y tế	Tổ QLCL	Các khoa phòng	DS. Thư	Có kế hoạch và kết quả				
81	Nhận, gửi, lưu trữ công văn, báo cáo liên quan đến hoạt động QLCL	Tổ QLCL	P.TCHC	DS. Thư	Có công văn được lưu giữ				
82	Đánh giá, khen thưởng CTCL	Tổ QLCL	P.TCHC	DS. Thư	Có danh sách được phê duyệt				
83	Khoa/phòng xây dựng mục tiêu chất lượng	Tổ QLCL	Các khoa phòng	DS. Thư	Tất cả khoa phòng có MTCL				
84	Tiếp nhận và xử lý sự cố y khoa	P.KHTH	Tổ QLCL	CN. Tài	Có hồ sơ lưu				
85	Tổng hợp, phân tích sự cố y khoa	P.KHTH	Tổ QLCL	CN. Tài	Có báo cáo				
86	Xây dựng, tổng hợp chỉ số chất lượng	Tổ QLCL	P.KHTH	DS. Thư	Có bộ CSCL được duyệt Có báo cáo, thống kê				
87	Tiến hành rà soát và đánh giá dựa trên bảng kiểm việc thực hiện phòng ngừa các nguy cơ, diễn biến xấu xảy ra với người bệnh tại các khu vực có nguy cơ cao hoặc đã xảy ra các sự cố	P.ĐD Các khoa LS	Tổ QLCL	H. Thái	Có bảng kiểm được đánh giá				

TT	NỘI DUNG THỰC HIỆN	Phụ trách	Phối hợp	Giám sát	Chỉ tiêu đánh giá	Kết quả đạt được			Ghi chú
						Đạt	Chưa đạt	Không thực hiện	
88	Kiểm tra việc tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật, thủ thuật	Khoa PT - GMHS	Tổ QLCL	CN. My	Có bảng kiểm được đánh giá				
89	Tự đánh giá và hoàn thành các tiêu chí của Bộ tiêu chí an toàn phẫu thuật, tối thiểu đạt mức 3	Khoa PT - GMHS	Tổ QLCL	CN. My	Có biên bản				
90	Rà soát tổng thể, lập danh sách các vị trí có nguy cơ trượt ngã và tiến hành xử lý	Tổ QLCL	P. TCHC	DS. Thư	Có danh sách				
91	Tổ chức lớp học tiền sản	K. Sản		BS. Nghĩa	Có sổ theo dõi				
92	Thống kê, thực hiện chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh sanh thường, sanh mổ (BSMHT, da kề da, mẹ nằm cùng con, tư vấn NCBSM, chăm sóc thiết yếu)	K. Sản		BS. Nghĩa	Có báo cáo				